BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Nouveautés de la semaine du 31 octobre 2026

3 nouveautés cette semaine, dont 1 susceptible de changer votre pratique.

RYTHMOLOGIE **Changement de pratique** Essai randomisé · LEAP-Block

Left Bundle-Branch Area Pacing vs Right Ventricular Pacing for Atrioventricular Block and Preserved Left Ventricular Function: The LEAP-Block Randomized Clinical Trial.

JAMA · 28 octobre 2026 · Essai randomisé de supériorité, 499 patients, 14 hôpitaux en Chine

Cet essai randomisé de supériorité, mené dans 14 hôpitaux chinois, a comparé la stimulation de l'aire de la branche gauche à la stimulation ventriculaire droite chez 499 patients porteurs d'un bloc auriculoventriculaire, avec une FEVG conservée d'au moins 50 % et une stimulation ventriculaire attendue supérieure à 40 %. À 24 mois, le critère composite associant décès toutes causes, événement d'insuffisance cardiaque et passage à une stimulation biventriculaire est survenu chez 2,4 % des patients stimulés dans la branche gauche contre 12,5 % avec la stimulation droite (différence absolue −10,1 % ; IC95 % −16,8 à −3,4 ; p = 0,003). Le bénéfice portait sur les événements d'insuffisance cardiaque (3,4 % contre 11,3 %), sans différence significative de mortalité ni de complications liées au dispositif.

> **En pratique :** chez le patient en bloc auriculoventriculaire à FEVG conservée chez qui l'on attend une stimulation ventriculaire supérieure à 40 %, cet essai randomisé plaide pour préférer la stimulation de l'aire de la branche gauche à la stimulation ventriculaire droite classique : une différence absolue de 10,1 points, soit environ dix événements du critère composite évités pour cent patients à deux ans, essentiellement des événements d'insuffisance cardiaque. La mortalité n'est pas significativement modifiée à deux ans, l'essai a été mené dans un seul pays, et la capture de la branche gauche n'a été confirmée que chez quatre patients sur cinq : le résultat suppose une technique maîtrisée.

Article original

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL **À connaître** Méta-analyse sur données individuelles

Performance of 0/1 h versus 0/3 h pathways in patients with suspected myocardial infarction: a systematic review and individual participant data meta-analysis of randomised controlled trials.

The Lancet · 29 octobre 2026 · Méta-analyse sur données individuelles de 5 essais randomisés, 110 933 passages

Cette méta-analyse sur données individuelles a réuni les cinq essais randomisés qui comparaient le parcours de troponine à 0 et 1 heure au parcours de référence à 0 et 3 heures chez des patients suspects d'infarctus, soit 110 933 passages aux urgences. À 30 jours, un décès ou un nouvel infarctus de type 1 est survenu dans 0,8 % des passages avec le parcours 0/1 h contre 1,0 % avec le parcours 0/3 h (OR 0,83 ; IC95 % 0,45–1,53), une estimation qui reste imprécise. Sur l'ensemble des essais, la durée de passage aux urgences n'était pas raccourcie (314 contre 308 minutes en médiane, sans différence démontrée) et la sortie directe n'était pas clairement plus fréquente (67,0 % contre 65,8 % ; OR 1,31 ; IC95 % 0,79–2,16), avec une forte hétérogénéité d'un essai à l'autre.

> **En pratique :** les taux d'événements à 30 jours sont faibles avec les deux parcours, mais l'estimation groupée du critère de sécurité reste imprécise et ne permet pas de conclure à une sécurité équivalente. Le gain de temps et de sorties directes attendu du redosage à 1 heure ne se vérifie pas en moyenne, et la forte hétérogénéité entre essais laisse penser qu'il varie d'un système de soins à l'autre. Pour un service qui envisage de passer du parcours 0/3 h au parcours 0/1 h, la décision doit tenir compte de l'ensemble du dispositif diagnostique et de l'organisation, et pas seulement de l'heure du second dosage.

Article original

PRÉVENTION Veille Essai randomisé · analyse secondaire préspécifiée · FLOWPROMOTE

Intensive vs More Intensive Lipid-Lowering Therapy and Plaque Regression in Statin-Naive Patients: Prespecified Analyses From the FLOWPROMOTE Randomized Clinical Trial.

JAMA Cardiology · 30 octobre 2026 · Analyse secondaire préspécifiée d'un essai randomisé, 104 patients

Dans l'essai FLOWPROMOTE, des patients n'ayant jamais reçu de statine, avec une coronaropathie stable nouvellement diagnostiquée au coroscanner (sténose supérieure à 50 % et FFR-CT inférieure ou égale à 0,80) ont été randomisés entre atorvastatine 40 mg et rosuvastatine 40 mg associée à l'ézétimibe 10 mg pendant 18 mois. Cette analyse secondaire préspécifiée a mesuré par coroscanner, à 9 et 18 mois, le volume de plaque sur l'ensemble de l'arbre coronaire chez 104 patients. Le LDL-cholestérol a baissé de 38 % avec le traitement intensif et de 65 % avec le traitement plus intensif. À 18 mois, le volume total de plaque avait reculé de 21,1 % avec le traitement plus intensif contre 13,6 % avec le traitement intensif (différence −30,9 mm³ ; IC95 % −57,2 à −4,5 ; p = 0,02), et la régression était d'autant plus marquée que le LDL atteint était bas.

> **En pratique :** chez le coronarien stable qui n'a jamais reçu de statine, le volume de plaque recule dès 18 mois dans les deux groupes, et davantage avec rosuvastatine 40 mg et ézétimibe qu'avec atorvastatine 40 mg seule ; la régression est d'autant plus marquée que le LDL atteint est bas. C'est un argument d'imagerie sur 104 patients, pas un résultat clinique : il conforte les cibles basses de LDL sans permettre de chiffrer un bénéfice sur les événements.

Article original

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.